

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

VERIFICA ADERENZA

ISO 7101 ALL. HTA / REG. UE 2021/2282 / AI GOVERNANCE

Area 11 – HTA

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL035_00	00	04/05/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Direttore Sanitario + RSGI	AD – Francesco Epifani	Riservato Alta Direzione + Direttore Sanitario	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente Istruzione di Lavoro disciplina la verifica documentale strutturata dei 14 documenti dell'Area 11 HTA del SGI di Toscana Diagnostica rispetto a tre driver normativo-strategici: (a) aderenza ai requisiti dell'Allegato A.4 di ISO 7101:2023 (Health Technology Assessment); (b) allineamento al Regolamento (UE) 2021/2282 sull'Health Technology Assessment (HTA Regulation europeo, in piena applicazione 2025-2030); (c) cross-reference fra i processi HTA e la procedura di AI Governance TD-SGI-PRO085 — per garantire che i sistemi AI adottati in TD passino attraverso il processo HTA prima dell'adozione operativa.

L'IDL si applica al perimetro dei 14 documenti HTA codificati nell'Area 11 (PRO022-024, MOD030-038, MOD046, MOD047) e al processo di Health Technology Assessment di TD nel suo insieme. La verifica è eseguita dal Direttore Sanitario con il supporto del RSGI con cadenza annuale e in occasione di ogni nuova adozione tecnologica significativa.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
ISO 7101:2023 Allegato A.4	Health Technology Assessment — componenti minime: technology scanning, evidence synthesis, economic evaluation, ethical assessment
Regolamento (UE) 2021/2282	HTA Regulation europeo — Joint Clinical Assessments (JCA) e Joint Scientific Consultations (JSC)
Reg. UE 2024/1689 (AI Act) art. 6-7	Classificazione sistemi AI ad alto rischio (incluso medical AI)
Reg. UE 2017/745 (MDR) + 2017/746 (IVDR)	Dispositivi medici e diagnostici in vitro
EUnetHTA HTA Core Model	Framework metodologico HTA
TD-SGI-PRO022, PRO023, PRO024	Procedure HTA esistenti
TD-SGI-MOD030 ÷ MOD038, MOD046, MOD047	Moduli operativi HTA esistenti
TD-SGI-PRO085	Procedura AI Governance (cross-reference)
TD-SGI-MOD197	Registro Sistemi AI
TD-SGI-MOD198	Scheda Onboarding Nuovo Sistema AI

3. Driver di verifica

3.1 Driver A — Aderenza ISO 7101:2023 Allegato A.4

L'Allegato A.4 di ISO 7101:2023 prevede che il processo HTA in una struttura sanitaria abbia quattro componenti minime:

- (a) TECHNOLOGY SCANNING (scansione delle tecnologie sanitarie disponibili o in arrivo);
- (b) EVIDENCE SYNTHESIS (sintesi delle evidenze cliniche disponibili — RCT, systematic reviews, real-world evidence);
- (c) ECONOMIC EVALUATION (valutazione economica — cost-effectiveness, budget impact, ROI clinico);

(d) ETHICAL ASSESSMENT (valutazione etica — equità di accesso, sicurezza paziente, impatti sociali).

La verifica deve dare evidenza che ciascuna delle 4 componenti sia presidiata in modo strutturato nei processi HTA di TD.

3.2 Driver B — Allineamento Reg. UE 2021/2282

Il Regolamento UE 2021/2282 introduce due strumenti di cooperazione europea: (a) Joint Clinical Assessment (JCA), valutazione clinica congiunta a livello UE per dispositivi medici di Classe IIb, III e IVD di Classe D + farmaci innovativi; (b) Joint Scientific Consultation (JSC), consulenza scientifica congiunta. La verifica deve dare evidenza che i processi HTA di TD considerino e integrino, ove disponibili, i JCA pubblicati dalla Commissione UE.

3.3 Driver C — Cross-reference HTA ↔ AI Governance

Con la diffusione dei sistemi AI in radiologia, anatomia patologica, biologia molecolare, è essenziale che ogni nuova adozione di sistema AI in TD passi attraverso la procedura HTA prima dell'introduzione operativa, in coordinamento con la PRO085 (AI Governance) e con il Registro Sistemi AI MOD197. La verifica deve dare evidenza dell'esistenza di un cross-reference esplicito.

4. Procedura operativa di verifica

Step	Attività	Output atteso	Owner
1	Estrazione dei 14 documenti HTA dall'indice REG006 (PRO022-024, MOD030-038, MOD046, MOD047)	Inventario documentale HTA	RSGI
2	Lettura puntuale dei contenuti delle 3 PRO HTA	Mappa delle attività HTA descritte nelle procedure	Direttore Sanitario + RSGI
3	Verifica aderenza Driver A — presenza delle 4 componenti minime ISO 7101 §A.4	Tabella aderenza ISO 7101 §A.4 con indicazione 'coperto' / 'parzialmente coperto' / 'da integrare'	Direttore Sanitario + RSGI
4	Verifica aderenza Driver B — riferimento ai JCA / JSC del Reg. UE 2021/2282	Esito: presenza riferimenti / assenza con raccomandazione di integrazione	Direttore Sanitario
5	Verifica aderenza Driver C — cross-reference HTA ↔ PRO085 AI Governance	Esito: presenza cross-reference / assenza con raccomandazione di integrazione	Direttore Sanitario + RSGI + IT Manager
6	Compilazione del Verbale di Verifica HTA con: aderenza Driver A/B/C, punti di forza, gap, raccomandazioni di integrazione	Verbale firmato Direttore Sanitario + RSGI	RSGI
7	Trasmissione del Verbale all'Alta Direzione + presentazione in Riesame della Direzione semestrale	Verbale acquisito al Riesame	RSGI + AD
8	Eventuali CAPA per chiusura gap rilevati (es. integrazione di una PRO HTA esistente, emissione nuovo MOD, formazione)	CAPA tracciate con owner e scadenze	RSGI + Direttore Sanitario

5. Cadenza e trigger

La verifica si esegue:

- (a) annualmente, di norma entro il 30 settembre di ogni anno, in tempo utile per l'aggiornamento del Riesame della Direzione di fine anno;
- (b) in occasione di ogni nuova adozione tecnologica significativa (nuova strumentazione diagnostica, nuovo sistema AI, nuovo kit IVD di classe C/D);
- (c) in occasione di pubblicazione di un nuovo Joint Clinical Assessment del Reg. UE 2021/2282 rilevante per le tecnologie in uso o in valutazione;
- (d) in occasione di ogni revisione maggiore di ISO 7101 o emanazione di nuovi atti delegati attuativi del Reg. UE 2021/2282;
- (e) su richiesta dell'Alta Direzione o del Direttore Sanitario.

6. Esiti possibili e azioni conseguenti

Esito	Significato	Azione
ADERENZA PIENA	Tutti i 3 driver sono coperti dai 14 documenti HTA esistenti	Mantenimento; nessuna CAPA
ADERENZA PARZIALE	Almeno un driver è coperto solo parzialmente (es. componente etica ISO 7101 non esplicita; mancato riferimento a JCA UE)	CAPA con integrazione dei documenti HTA esistenti entro 6 mesi
GAP RILEVANTE	Almeno un driver è scoperto in modo significativo	Riesame straordinario; CAPA con integrazioni o emissioni di nuovi documenti entro 12 mesi
FUORI PERIMETRO (eccezionale)	Specifico aspetto del driver dichiarato dall'Alta Direzione fuori scope SGI per scelta strategica motivata	Tracciato con motivazione opponibile in audit di terza parte

7. KPI di processo

KPI	Target
% verifiche annuali completate nei tempi	100%
Tempo medio dalla rilevazione di gap alla chiusura della CAPA	≤ 180 giorni
Numero JCA UE 2021/2282 valutati e integrati	Tracciato (dipende dalle pubblicazioni UE)
Numero sistemi AI passati per HTA prima dell'adozione operativa	100% dei sistemi AI ad alto rischio
% verbali HTA presentati in Riesame della Direzione	100%

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	04/05/2026	Prima emissione dell'Istruzione di Lavoro per la verifica documentale dell'aderenza dei 14 documenti HTA dell'Area 11 ai 3 driver: ISO	Direttore Sanitario + RSGI	AD

		7101:2023 Allegato A.4 (4 componenti minime: technology scanning, evidence synthesis, economic evaluation, ethical assessment), Regolamento (UE) 2021/2282 (JCA + JSC), cross-reference HTA ↔ PRO085 AI Governance. Procedura operativa a 8 step. Cadenza annuale entro 30/09 + trigger ad-hoc. 4 esiti possibili con azioni conseguenti.		
--	--	---	--	--